

# แนวคิดการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการ ผ่าตัด (Perioperative Nursing Care)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจน์นิชา เรืองชัยทวิสุข  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

# วัตถุประสงค์: นิสิตสามารถ

1. อธิบายวัตถุประสงค์ และประเภทของการผ่าตัดได้
2. อธิบายการตอบสนองทางด้านร่างกายต่อการผ่าตัดได้
3. อธิบายระยะของการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดได้
4. อธิบายการพยาบาลผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัดได้
5. อธิบายการพยาบาลผู้ป่วยในระยะขณะผ่าตัดได้
6. อธิบายการพยาบาลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัดทันทีที่ห้องผ่าตัดและในระยะต่อมาที่หอผู้ป่วยได้

# แนวคิดการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (Perioperative Nursing)

## แบ่งตามความรีบด่วน

**Elective Surgery** : มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่รีบด่วน ไม่คุกคามกับชีวิต เช่น Hemorrhoidectomy

**Urgent Surgery** : เป็นการผ่าตัดที่ต้องรีบทำ ถ้าเลื่อนออกไปอาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยได้ ควรจะทำทันทีเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อคงไว้ซึ่งความมีสุขภาพดีเช่นเดิมของผู้ป่วย เช่น การผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบจากการแตกทะลุเข้าไปในช่องท้อง ทำให้ติดเชื้อในช่องท้อง

**Emergency Surgery** : เป็นการผ่าตัดทันทีอย่างรีบด่วน เป็นภาวะฉุกเฉินเพื่อรักษาชีวิต ผู้ป่วยไว้ เช่น Severe trauma, Gun shot และ Stab wounds

## แบ่งตามขนาดและความรุนแรง

การผ่าตัดใหญ่ (Major surgery)

การผ่าตัดเล็ก (Minor surgery)



# Response to hormone secretion

| Hormone                              | Physiological effect                                                                                                                                                          | Patient response                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norepinehine                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Peripheral vasoconstriction</li><li>- Decrease Gastrointestinal function</li></ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Maintain blood pressure</li><li>- Constipation</li></ul>                                                                                |
| Glucocorticoids                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gluconeogenesis</li><li>- Negative nitrogen balance</li><li>- Decrease immune response</li><li>- Increase platelet activity</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Increase energy feeds</li><li>- Decrease tissue repair</li><li>- Increase risk of infection</li><li>- Increase clot formation</li></ul> |
| Aldosterone and antidiuretic hormone | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sodium and water reabsorption</li></ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Decrease urine output</li><li>- Increase circulatory volume</li></ul>                                                                   |

# การตอบสนองทางด้านจิตใจต่อการผ่าตัด

Fear of unknown

Loss of control

Permanent limitation

Disfigurement

Pain

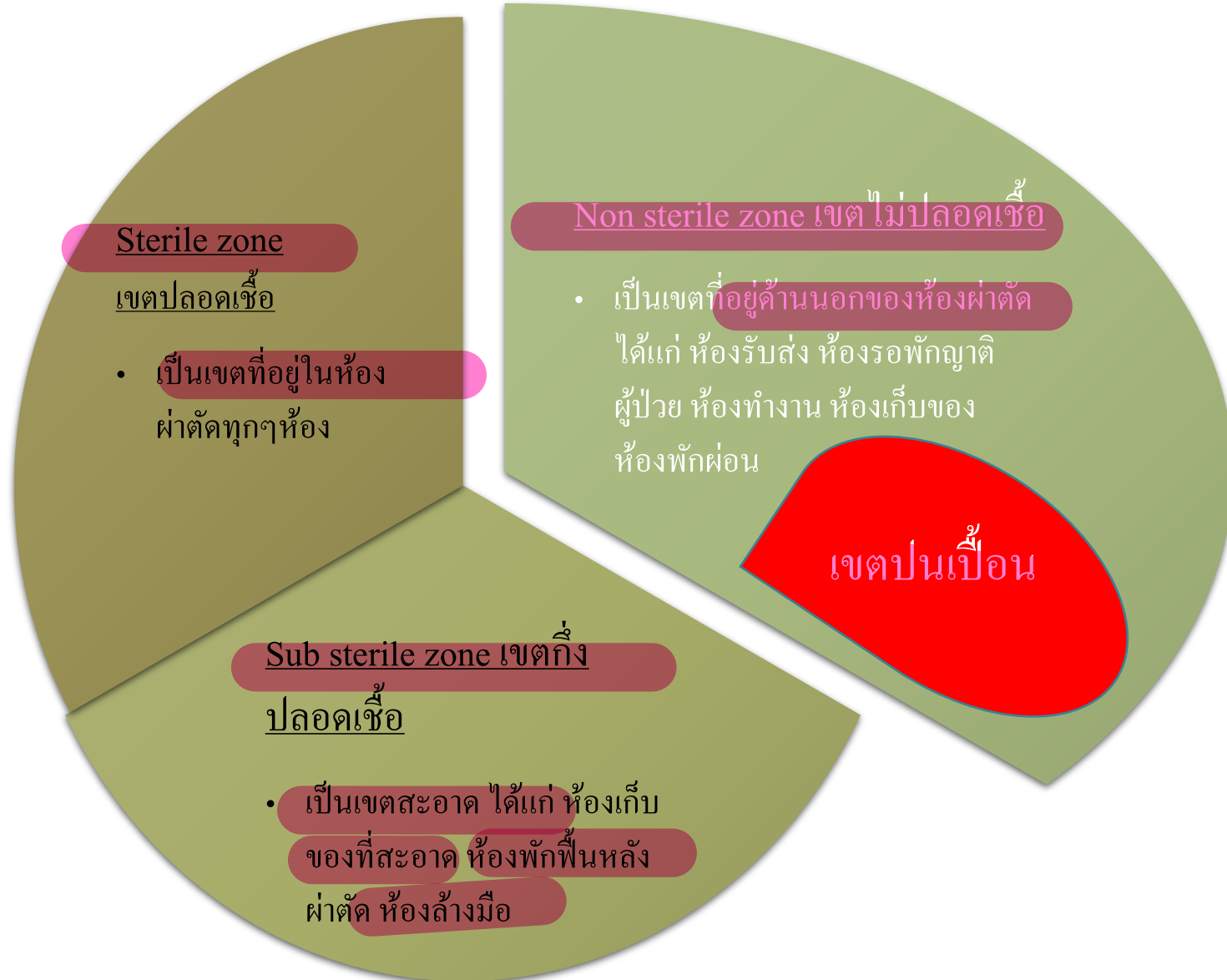
Threat of sexuality



# โครงสร้างของห้องผ่าตัดและทีมผ่าตัด

|                                                                                    |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | ห้องผ่าตัดเป็นห้องที่จัดเตรียมไว้สำหรับทำผ่าตัด |
|                                                                                    | ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากที่สุด            |
|                                                                                    | ต้องมีการออกแบบที่ถูกต้อง                       |
|                                                                                    | มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ที่สมบูรณ์             |
|                                                                                    | มีระบบการป้องกันการติดเชื้อที่ดี                |
|                                                                                    | ทีมผ่าตัดมีความพร้อม มีความรู้                  |
|                                                                                    |                                                 |
|                                                                                    |                                                 |
|                                                                                    |                                                 |
|                                                                                    |                                                 |
|                                                                                    |                                                 |

# การแบ่งพื้นที่ภายในห้องผ่าตัด



# ห้องต่างๆในตึกผ่าตัด

## ห้องผ่าตัด (Operating room)

- มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นในห้องผ่าตัด
- ขนาดห้อง 20x 20 ฟุต หรือ 18 x 20 ฟุต หรือไม่เล็กกว่า 14 x 16 ฟุต
- ควรมีสายดินฝังที่พื้นห้อง

- ฝาห้องควรเป็นกระจกฝ้า
- ประตู ควรเป็น swing door
- มีแสงสว่างเพียงพอ
- มี pipe line
- อุณหภูมิห้อง 18-21 ° C
- ใช้ air condition



# ห้องต่างๆในตึกผ่าตัด (ต่อ)



ห้องผ่าตัด  
(Operating room)



# ห้องต่างๆในตึกผ่าตัด (ต่อ)

ห้องรับส่งผู้ป่วย  
(Stretcher room)



# ห้องต่างๆในตึกผ่าตัด (ต่อ)



ห้องรอผ่าตัดสำหรับ  
ผู้ป่วยและญาติ  
(Patient waiting room)





# ห้องต่างๆในตึกผ่าตัด (ต่อ)

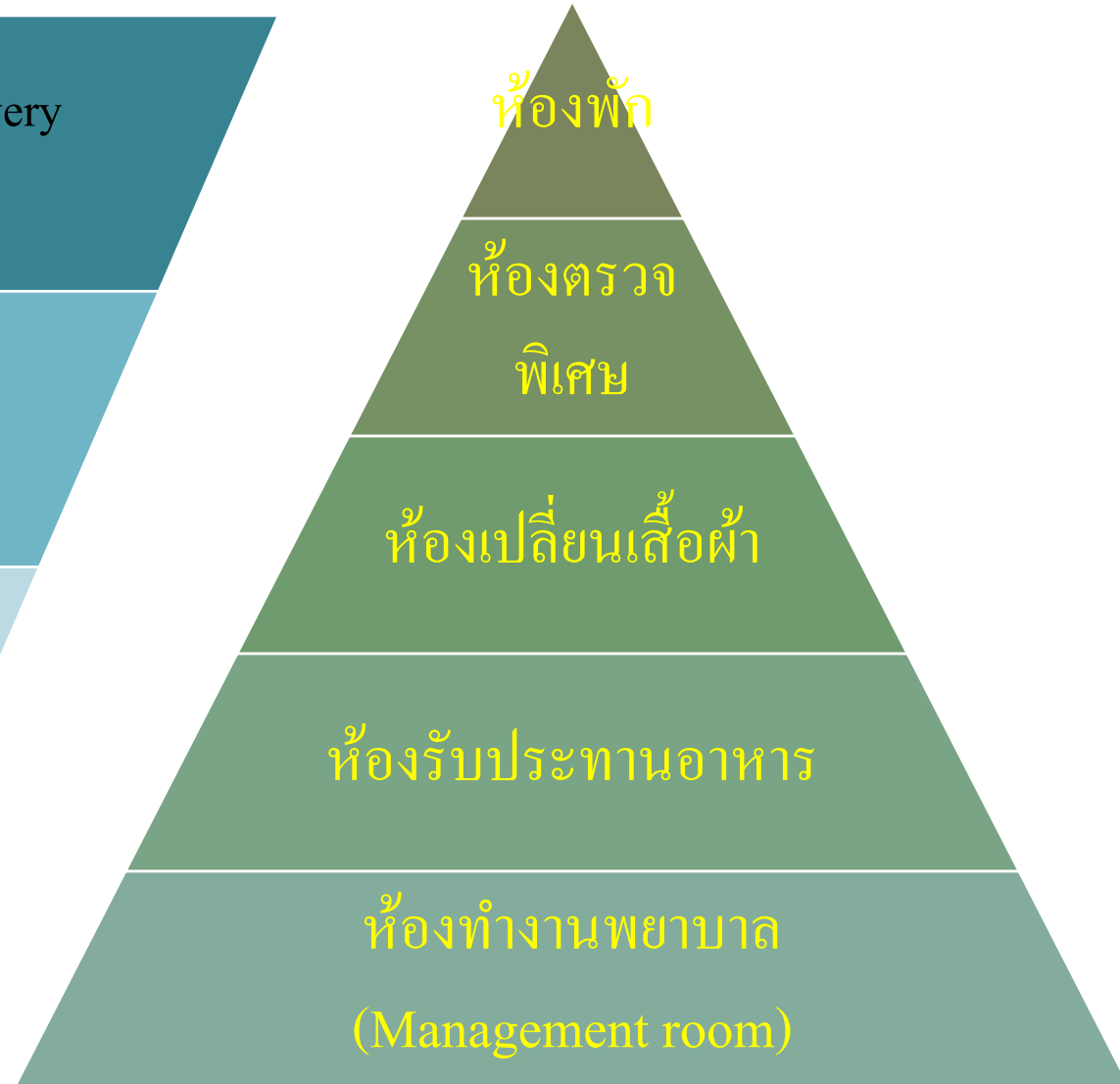
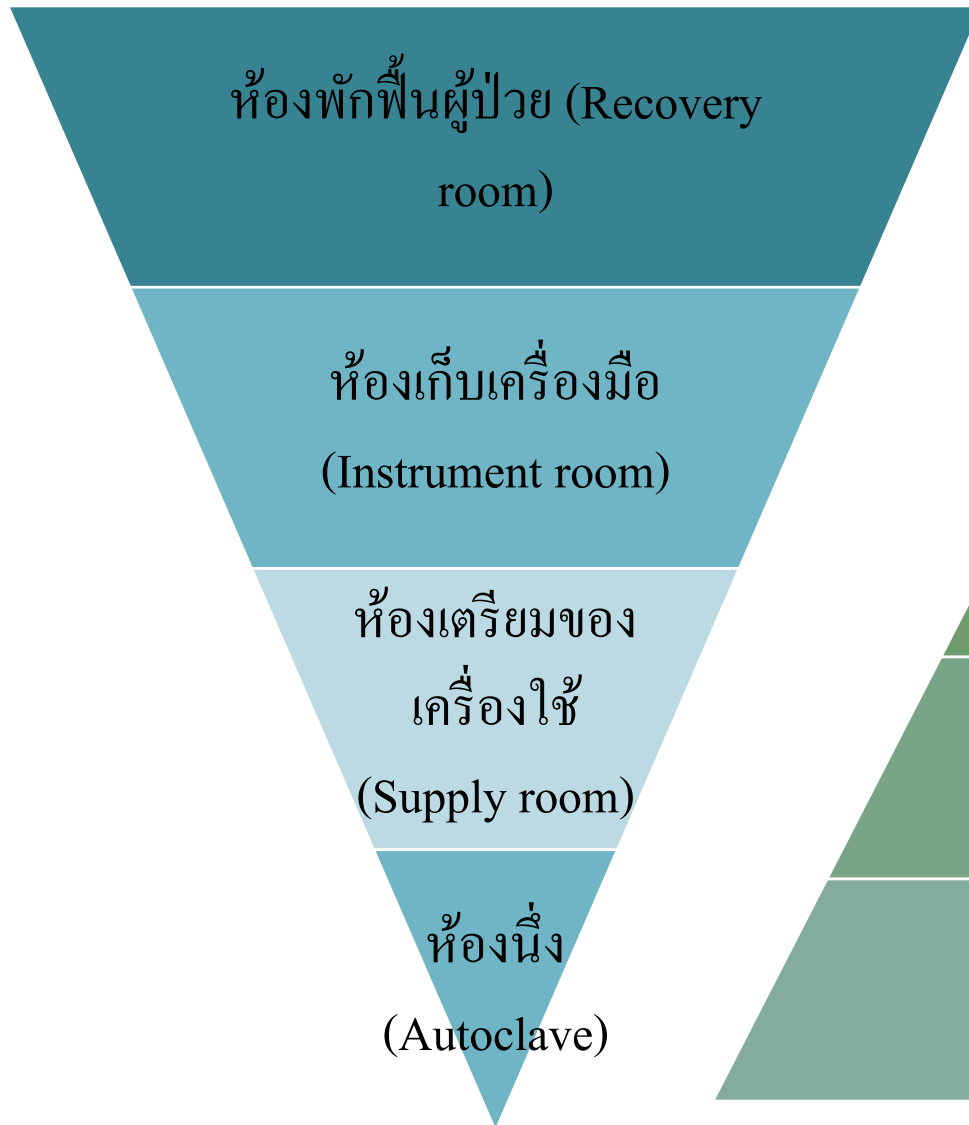


ห้องล้างมือ  
(Scrubbing room)

ห้องให้ยาระงับความรู้สึก  
(Patient waiting room)



# ห้องต่างๆในตึกผ่าตัด (ต่อ)



# ทีมผ่าตัด

ทีมผ่าตัด ประกอบด้วย



แพทย์ผ่าตัด/ผู้ช่วยผ่าตัด

วิสัญญีแพทย์/วิสัญญี  
พยาบาล



- Scrub nurse
- Circulating nurse
- คณิกา
- เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ประจำห้องผ่าตัด

# การป้องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด Infection control

- ☐ มีการออกแบบที่ถูกต้อง
- ☐ มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ครบถ้วนเพียงพอ
- ☐ บรรยากาศเอื้อต่อการผ่าตัด
- ☐ พื้นควรเป็นวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า
- ☐ มี filtered air supply
- ☐ อุณหภูมิเหมาะสม 20-26 ° C

# การป้องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด Infection control (ต่อ)

- ☐ ต้องไม่อยู่ไกลจาก OPD, Pathologic department, Central supply, X-rays, ICU, ER
- ☐ จำนวนห้องผ่าตัดเพียงพอ
- ☐ ประตูห้องผ่าตัดควรปิดตลอดเวลา
- ☐ ภายในห้องผ่าตัดควรเป็นห้องโล่ง
- ☐ แสงสว่างเพียงพอ



# การทำความสะอาดห้องผ่าตัด

## พื้นห้องผ่าตัด

- เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ
- ทำความสะอาดทุกเช้าและเย็น หรือหลังผ่าตัดเสร็จแต่ละราย

## ภายในห้องผ่าตัด

- เช็ดทุกเช้าก่อนเริ่มทำผ่าตัด ด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ
- เช็ดบริเวณไฟผ่าตัดผนังห้อง ตู้เก็บของ โต๊ะ และเตียงผ่าตัด (เรียงตามลำดับ)

## อ่างล้างมือ

- ทำความสะอาดอ่างล้างมือทุกเช้าและทุกครึ่งหลังล้างมือเข้าทำผ่าตัด

## อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ

- ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ของห้องผ่าตัดทุกสัปดาห์
- ตรวจสอบ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

# การทำความสะอาดห้องผ่าตัด (ต่อ)

## ห้องต่างๆ ภายในตึก

- ทำความสะอาดห้องต่างๆ ภายในตึกผ่าตัดโดยเช็ดถูพื้นห้อง ตู้เก็บของต่างๆ ทุกวัน

## เครื่องมือปลอดเชื้อ

- เครื่องมือที่ทำให้ปลอดเชื้อแล้ว หากเกิน 21 วัน (3 สัปดาห์) ควรนำไปทำให้ปลอดเชื้อใหม่ ก่อนนำมาใช้

## กำหนดวันทำความสะอาด

- กำหนดให้มีการทำความสะอาดพิเศษเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน เช่น การทำความสะอาดผนังห้อง พื้นห้องผ่าตัด เครื่องทำความเย็น

# การทำความสะอาดหลังการทำผ่าตัดที่มีการติดเชื้อ



# การทำความสะอาดหลังการทำผ่าตัดที่มีการติดเชื้อ (ต่อ)



# การทำความสะอาดหลังการทำผ่าตัดที่มีการติดเชื้อ (ต่อ)



# ข้อควรปฏิบัติในห้องผ่าตัด

1. บุคลากรทุกคนในห้องผ่าตัดต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า รองเท้า สวมหมวก  
ของห้องผ่าตัดก่อนเข้าห้องผ่าตัด และไม่ควรใส่เครื่องประดับใดๆขณะ  
ปฏิบัติงาน ห้ามสวมเสื้อผ้าชุดห้องผ่าตัด ออกนอกตึกผ่าตัด

2. ควรทำความสะอาดเสื้อผ้า รองเท้า หมวก ผ้าปิดปาก-จมูกทุกวัน

3. เมื่อเข้าสู่เขตปลอดเชื้อต้องสวมหมวก และผ้าปิดปาก-จมูกตลอดเวลา

4. ควรทำความสะอาดห้องผ่าตัดให้เสร็จ ก่อนเริ่มผ่าตัด 1-2 ชม. เสมอ

## ข้อควรปฏิบัติในห้องผ่าตัด (ต่อ)

5. ควรป้องกันการแพร่กระจายเชื้อภายในห้องผ่าตัด

5.1 ภายในห้องผ่าตัดต้องปรับให้มีอุณหภูมิและความชื้นที่  
พอเหมาะ มีระบบหมุนเวียนอากาศ 15-20 ครั้งต่อ ชม. มีระบบ  
กรองอากาศ

5.2 ขณะทำผ่าตัด ประตู หน้าต่างควรปิดอยู่เสมอ ควรให้มีการ  
เคลื่อนไหวของอากาศ การพูดคุย การผ่านเข้าออกในห้องทำ  
ผ่าตัดให้น้อยที่สุด

## ข้อควรปฏิบัติในห้องผ่าตัด (ต่อ)

5.3 ภายหลังเสร็จผ่าตัดและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปส่งที่หอผู้ป่วยแล้ว ผ้าที่คลุมของผู้ป่วยไม่ควรนำมาใช้ในห้องผ่าตัดอีก

5.4 บุคลากรห้องผ่าตัดต้องยึดหลัก Universal precaution อย่างเคร่งครัด และใช้เทคนิคปลอดเชื้ออย่างถูกต้อง

5.5 ควรมีการทำความสะอาด ห้องผ่าตัด อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และทำลายเชื้อโรค ภายหลังเสร็จผ่าตัดทุกครั้ง



# แนวคิดการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (Perioperative Nursing)

**ระยะที่ 1 ระยะก่อนผ่าตัด (Pre-operative phase)** มีเป้าหมายการดูแลคือ การประเมินปัญหาผู้ป่วย เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อผู้ป่วยจะได้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัด ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน ช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็ว และใช้เวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลน้อยที่สุด

**ระยะที่ 2 ระยะขณะผ่าตัด (Intra-operative phase)** เป้าหมายการดูแลคือ เพื่อให้ได้รับความปลอดภัย จากการได้รับยาสงบระงับ และดูแลผู้ป่วยขณะทำผ่าตัด รวมทั้งหลังผ่าตัดทันทีในห้องผ่าตัด

**ระยะที่ 3 ระยะหลังผ่าตัด (Post-operative phase)** เป้าหมายการดูแลคือ การช่วยเหลือให้ผู้ป่วยฟื้นจากยาระงับความรู้สึก คงไว้ซึ่งการทำงานที่ปกติของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ช่วยระงับความเจ็บปวด ป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด และป้องกันความไม่สุขสบายต่าง ๆ ของร่างกาย

ผู้ป่วยทราบว่า → เข้าห้องผ่าตัด → อยู่ห้องพักรฟื้น → กลับหอผู้ป่วย

ต้องผ่าตัด



# ปัญหาและการพยาบาลผู้ป่วยในแต่ละระยะของการผ่าตัด

ปัญหาและการพยาบาลผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด

ปัญหาและการพยาบาลผู้ป่วยในระยะขณะผ่าตัด

ปัญหาและการพยาบาลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

# ระยะก่อนผ่าตัด

ปัญหาและการพยาบาล

# ปัญหาในระยะก่อนผ่าตัด

## ความกลัวและวิตกกังวล

- ❖ กลัวการเสียชีวิตขณะผ่าตัด
- ❖ การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัด
- ❖ การขาดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด
- ❖ การที่ต้องถูกตัดอวัยวะที่จะทำให้เกิดความพิการตามมา
- ❖ สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย การถูกแยกจากบุคคลในครอบครัว
- ❖ การถูกเปิดเผยร่างกาย
- ❖ ความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นหลังผ่าตัด

## ปัญหาในระยะก่อนผ่าตัด (ต่อ)

### ความพร้อมทางด้านร่างกายก่อนได้รับการผ่าตัด

- การซักประวัติ การตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- การประเมินการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด
- การประเมินความสามารถในการทำงานของระบบทางเดินหายใจ
- การประเมินการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ
- การเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัด

การงดน้ำและอาหาร ด้านการขับถ่ายอุจจาระ ด้านการขับถ่ายปัสสาวะ ผิวหนัง การฝึกการหายใจลึกและการไอ การออกกำลังกาย การลุกเดินเร็ว การเซ็นใบยินยอมผ่าตัด การส่งผู้ป่วยไปห้องผ่าตัด

# การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด : ความกลัวและความวิตกกังวล

## การประเมินความกลัวและความวิตกกังวลของผู้ป่วย

จากผลการวิจัยพบว่าความกลัวและวิตกกังวลจะส่งผลต่อการฟื้นหายของผู้ป่วย และทำให้ความต้องการในการใช้ยาแก้ปวดเพิ่มมากขึ้น

การตอบสนองของร่างกายเมื่อเกิดความกลัว

*การหลั่งสาร Epinephrine และ Norepinephrine ทำให้เกิดอาการ HR เร็วขึ้น BP เพิ่มสูงขึ้น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงเกิดการเจ็บแน่นหน้าอก เป็นต้น*

การประเมินผู้ป่วยทำได้โดย: การวัดสัญญาณชีพ การสังเกตพฤติกรรม เช่น การเคลื่อนไหวมาก หรือน้อยผิดปกติ การพูดทวนซ้ำ ๆ เรื่องเดิม พูดเร็ว กระสับกระส่าย ถอนหายใจบ่อย ร้องไห้

# การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด : ความกลัวและความวิตกกังวล

## กิจกรรมการพยาบาล

**อธิบายให้ข้อมูล:** การผ่าตัด ลักษณะและลักษณะและชนิดของการผ่าตัด ระยะเวลาที่อยู่ในห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น การให้ยา ระวังความรู้สึกขณะผ่าตัด รวมทั้งแจ้งให้ผู้ป่วยทราบสถานการณ์ที่ผู้ป่วยต้องเผชิญ และอธิบายเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ปกติหรือสถานการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

**วัตถุประสงค์** เพื่อช่วยให้เกิดการปรับตัวที่เหมาะสม การยอมรับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ จะต้องให้ข้อมูลในระยะตั้งแต่ก่อนผ่าตัด เพราะผู้ป่วยจะสามารถทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ และเตรียมการจัดการความเครียดและวิตกกังวลได้อย่างเหมาะสม



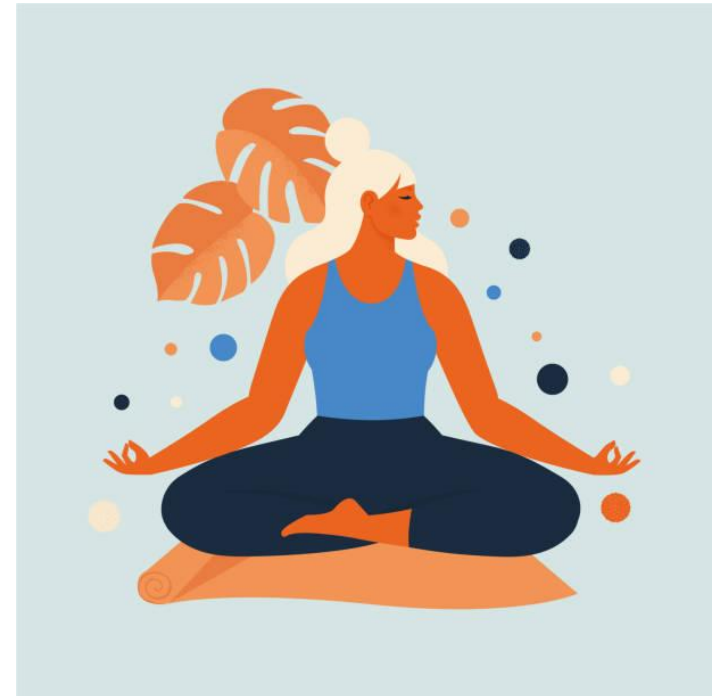


# การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด

## : ความกลัวและความวิตกกังวล

### กิจกรรมการพยาบาล

- ❖ การเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัด
- ❖ แลกเปลี่ยนกับผู้ป่วยที่มีประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับการผ่าตัด: บรรเทาความกลัวและวิตกกังวลลงได้
- ❖ ประเมินความเข้าใจของครอบครัว: เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- ❖ เทคนิคการลดความวิตกกังวล: การหายใจ การเบี่ยงเบนความสนใจ



# การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด : การประเมินความพร้อมด้านร่างกาย

การซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

**เป้าหมายการประเมิน:** ค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลต่อการผ่าตัด

- ❖ ซักประวัติ: CC, PI, PH, Family history illness
- ❖ ประวัติการแพ้: ยา อาหาร สารต่าง ๆ
- ❖ อายุ ภาวะโภชนาการ ความสมดุลของน้ำและอาหาร
- ❖ ประเมินรูปร่าง: เพื่อเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ยาระงับความรู้สึก อุปกรณ์การผ่าตัด

# การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด

## : การประเมินความพร้อมด้านร่างกาย

### การซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ต่อ)

- ❖ ประเมินข้อจำกัดของร่างกาย เช่น ความพิการ อาการปวดขณะเคลื่อนไหว ข้อจำกัดด้านภาษา: เพื่อวางแผนการจัดทำผู้ป่วยสำหรับการผ่าตัด
- ❖ อุปกรณ์เทียม เช่น ฟันปลอม: ลดอันตรายขณะใส่ท่อช่วยหายใจขณะทำผ่าตัด
- ❖ เครื่องประดับ ของมีค่า: ลดอันตรายจากการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้า
- ❖ ประเมินเกี่ยวกับการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker): หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้าชนิด Monopolar (อาจจะทำให้ไฟฟ้าส่งผ่านไปยังเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ)

ถอดของมีค่าต่างๆ



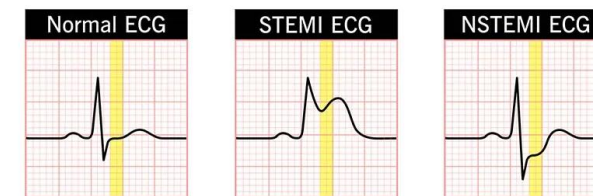
# การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด

## : การประเมินความพร้อมด้านร่างกาย

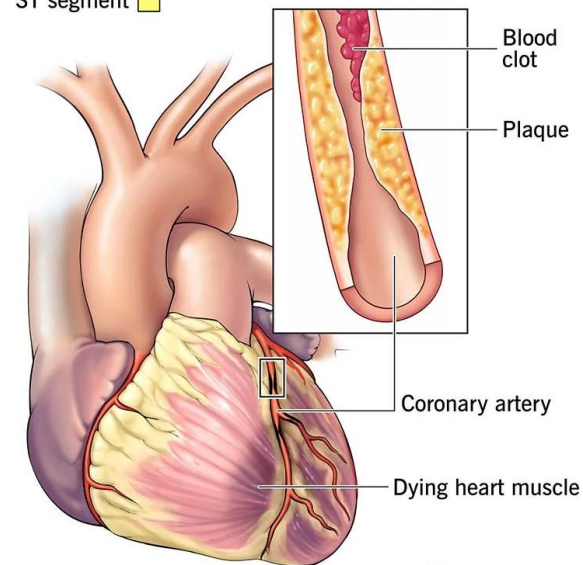
### การทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด

**วัตถุประสงค์:** ดูความสามารถในการส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย โดยดูปริมาณของเลือด คุณภาพของเลือด

- ❖ ซักประวัติเกี่ยวกับการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด: โรคความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะ
- ❖ กิจกรรมการประเมิน: V/S, ประเมินภาวะซีด (Conjunctiva, Capillary refilling time, CBC ดู Hct. WBC. Plt., EKG (กรณีอายุเกิน 40 ปี)



ST segment



# การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด : การประเมินความพร้อมด้านร่างกาย

## การทำงานของระบบทางเดินหายใจ

วัตถุประสงค์: ดูความสามารถในการทำงานของปอดและหลอดลม

ซักประวัติ: การเจ็บป่วยด้วยโรคหอบหืด การสูบบุหรี่ โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ COPD

ดูผลการตรวจทางรังสีวิทยา: Chest x-ray

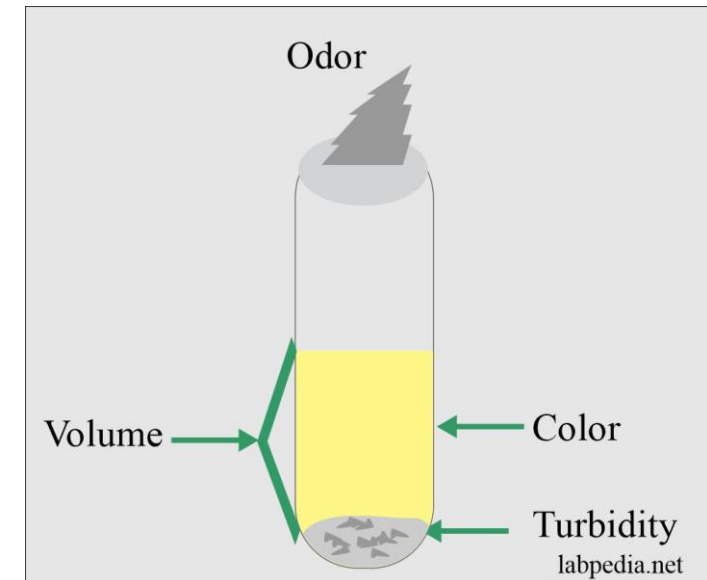
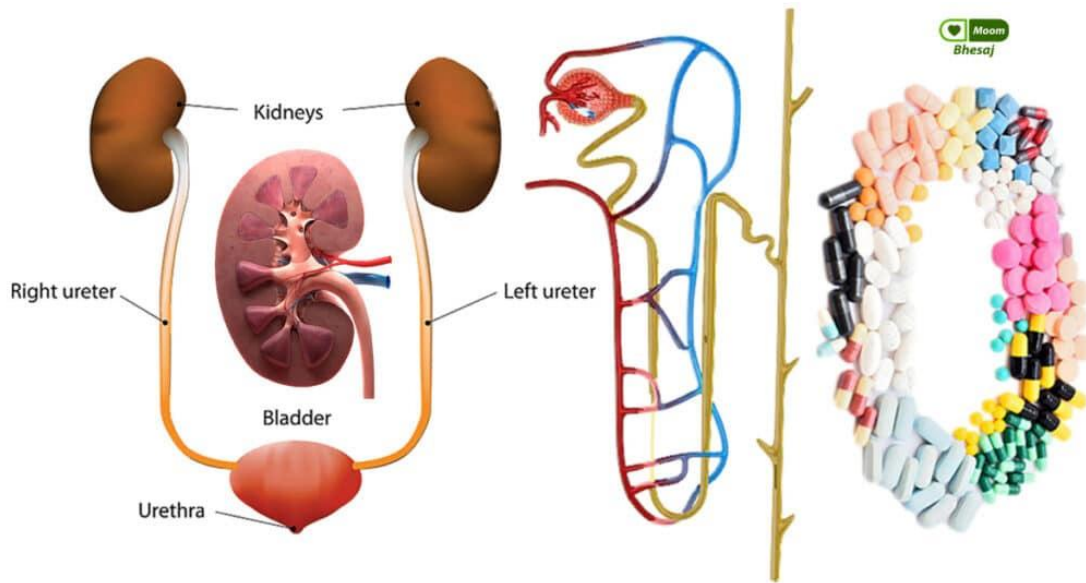
ตรวจร่างกาย: ฟังปอด ชั่งปาก การอ้าปาก การแหงนหน้า (เพื่อเตรียมความพร้อมในการดมยาสลบ)





# การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด

## : การประเมินความพร้อมด้านร่างกาย



### การทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ

วัตถุประสงค์: ประเมินความสามารถในการขับยาหรือสารพิษออกจากร่างกายที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับยาระงับความรู้สึก

ดูแล Lab: BUN, Cr, UA (pH, Urine specific gravity, Protein, Glucose, RBC, WBC, Epithelial cell)

# การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด

## : การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัด

### การงดน้ำงดอาหาร

**วัตถุประสงค์:** ป้องกันการสำลักเอาน้ำหรือเศษอาหารหรือสิ่งคัดหลั่งเข้าไปในทางเดินหายใจในขณะที่ผู้ป่วยได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย

- กรณีได้รับยาระงับความรู้สึกชนิดทั่วร่างกาย (General anesthesia) จะต้องงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ในคืนก่อนผ่าตัด
- กรณีได้รับยาระงับความรู้สึกแบบเฉพาะที่ (Regional anesthesia) ควรงดน้ำและอาหารอย่างน้อยควรเป็น 4-6 ชั่วโมง

# การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด

## : การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัด

### การงดน้ำงดอาหาร

**วัตถุประสงค์:** ป้องกันการสำลักเอาน้ำหรือเศษอาหารหรือสิ่งคัดหลั่งเข้าไปในทางเดินหายใจในขณะที่ผู้ป่วยได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย

- กรณีได้รับยาระงับความรู้สึกชนิดทั่วร่างกาย (General anesthesia) จะต้องงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ในคืนก่อนผ่าตัด
- กรณีได้รับยาระงับความรู้สึกแบบเฉพาะที่ (Regional anesthesia) ควรงดน้ำและอาหารอย่างน้อยควรเป็น 4-6 ชั่วโมง

**\*กรณีผู้ป่วยได้รับยา Warfarin ให้ผู้ป่วยงดยาก่อนผ่าตัด 7 วัน**



# การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด

## : การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัด

### การขับถ่าย: อุจจาระ

(กรณีผ่าตัดใหญ่ที่เปิดเข้าช่องท้อง กระเพาะอาหาร ลำไส้ ทวารหนัก บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์)

**วัตถุประสงค์:** ป้องกันไม่ให้อุจจาระไหลออกมาขณะทำผ่าตัด ลดการเกิดการสัมผัสปนเปื้อนจากอุจจาระในระหว่างการผ่าตัด เนื่องจากกล้ามเนื้อหูรูดบริเวณทวารหนักคลายตัวในขณะที่ได้รับการระงับความรู้สึก

### วิธีปฏิบัติ

- ทำการสวนในวันก่อนผ่าตัด

# การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด

## : การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัด

### การการขยับถ่ายปัสสาวะ

(กรณีทำการผ่าตัดในอวัยวะที่ใกล้กับกระเพาะปัสสาวะ แต่ถ้าเป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะแพทย์ต้องการให้มีน้ำในกระเพาะปัสสาวะให้มาก)

**วัตถุประสงค์:** ป้องกันการปัสสาวะราดขณะทำผ่าตัด และเพื่อให้เห็นอวัยวะที่ต้องการทำผ่าตัดได้อย่างชัดเจน

### วิธีปฏิบัติ

- อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจ
- ใส่สายสวนปัสสาวะชนิดค้างไว้

# การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด

## : การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัด

### การเตรียมผิวหนังบริเวณที่จะผ่าตัด (Skin preparation)

**วัตถุประสงค์:** เพื่อลดจำนวนเชื้อโรคบริเวณผิวหนังที่จะผ่าตัดให้น้อยที่สุด

#### วิธีปฏิบัติ

- โกนขนและฟอกด้วยสบู่ยา (ในกรณีที่มีคำสั่งจากแพทย์)
- เตรียมให้กว้างกว่าบริเวณที่จะผ่าตัดจริง รัศมีประมาณ 8-12 นิ้ว (กว้างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้)
- ทำตอนบ่ายหรือตอนเย็นวันก่อนผ่าตัด หรือทำในห้องผ่าตัดก่อนเริ่มผ่าตัด
- กรณีทำการผ่าตัดบริเวณช่องคลอด : โกนขน และ สวนล้างช่องคลอด
- กรณีทำการผ่าตัดบริเวณ ช่องปากและคอ : ทำความสะอาดปากและฟันโดยการบ้วนปากด้วยน้ำยาระงับเชื้อในคินก่อนผ่าตัด และเข้าก่อนจะเข้าห้องผ่าตัด

# การเตรียมผิวหนังบริเวณที่จะผ่าตัด

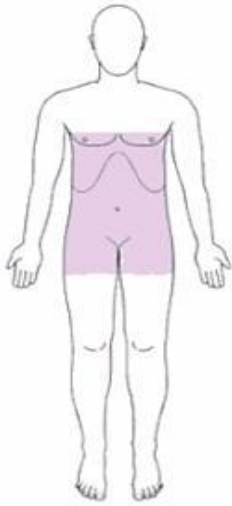


Fig. 3.1 Preparation of site: abdomen

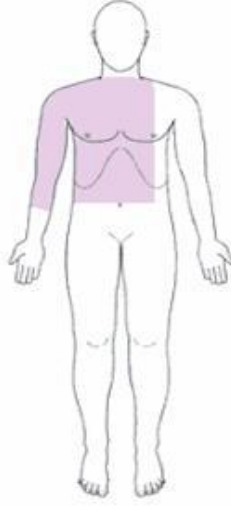


Fig. 3.2 Preparation of site: chest/breast

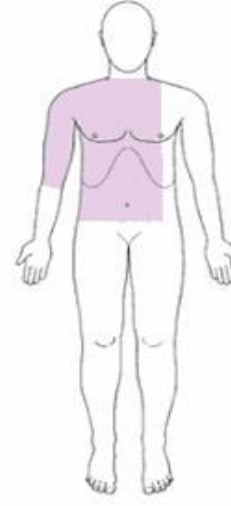


Fig. 3.3a Preparation of site: lateral/thoracotomy

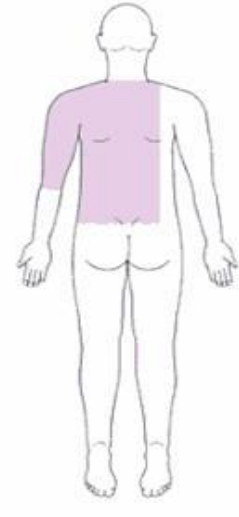


Fig. 3.3b Preparation of site: lateral/thoracotomy

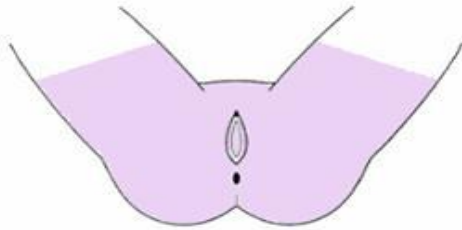


Fig. 3.4 Preparation of site: rectoperitoneal/vaginal

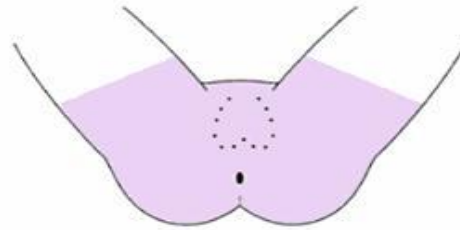


Fig. 3.5a Preparation of site: abdominal/perineal

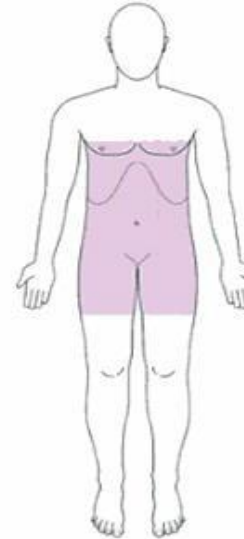


Fig. 3.5b Preparation of site: abdominal/perineal

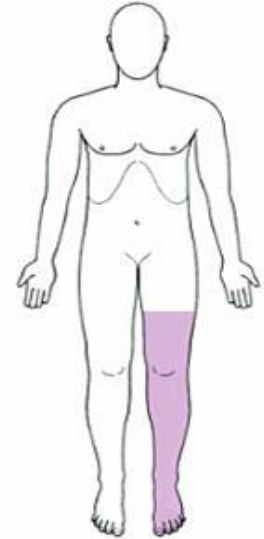


Fig. 3.6 Preparation of site: knee/lower leg

# การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด

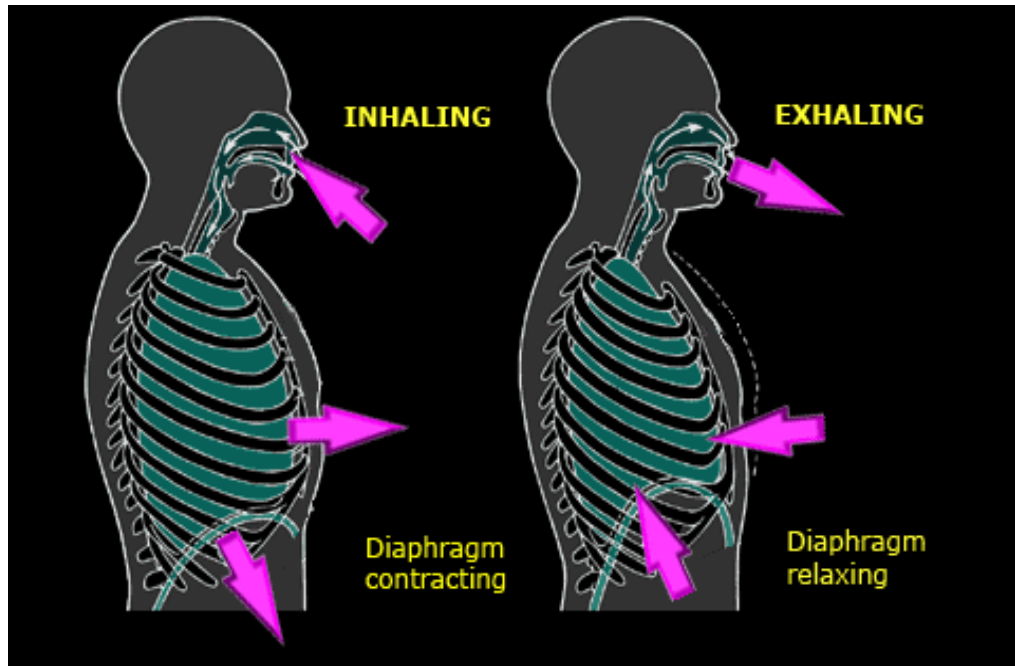
## : การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัด

### การฝึกการหายใจลึกและการไอ (Deep breathing and coughing exercise)

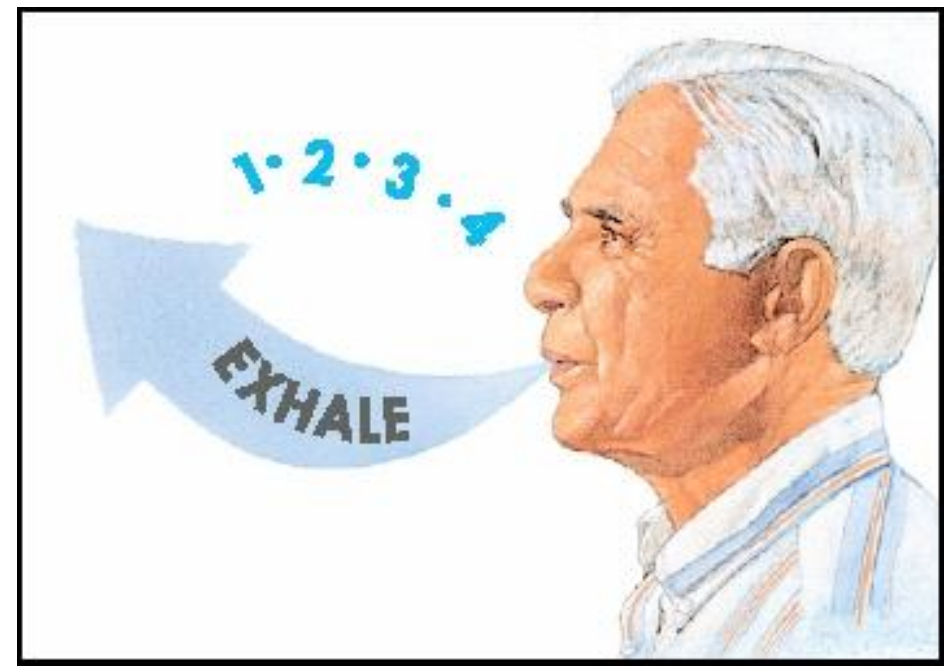
**วัตถุประสงค์:** ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาหลังผ่าตัดที่สำคัญเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ปอดแฟบ ปอดบวม ปอดอักเสบ เสมหะคั่ง หายใจลำบาก เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ จากฤทธิ์ของยาระงับความรู้สึกและยาแก้ปวด ทำให้การทำงานของ cilia ของเยื่อบุทางเดินหายใจลดลง และศูนย์หายใจในสมองถูกกด

#### วิธีปฏิบัติ

- Deep breathing exercise
- Pursed-lip-breathing exercise
- การส่งเสริมการไออย่างมีประสิทธิภาพ



-Deep breathing exercise



Pursed-lip-breathing exercise



การส่งเสริมการไออย่างมีประสิทธิภาพ

# การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด

## : การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัด

### การออกกำลังกาย (Leg exercise)

**วัตถุประสงค์:** ส่งเสริมให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น ลดการคั่งของหลอดเลือดดำส่วนปลายขาและลดการบวมของขา ป้องกันการเกิดหลอดเลือดอักเสบ และส่งเสริมให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงดีขึ้น

**ภาวะแทรกซ้อนกรณีไม่ปฏิบัติ:** DVT (Deep vein thrombosis), Thrombophlebitis

### วิธีปฏิบัติ

- นอนหงายราบหรือนอนศีรษะสูง ขาเหยียดตรง - ยกต้นขาขึ้น งอเข่าซ้ายหรือขวาขึ้นสูงจากที่นอนเท่าที่จะสามารถทำได้ นาน 2-3 วินาที
- นอนเหยียดขาตรงและค่อยๆวางลงบนที่นอน - หมุนข้อเท้าตามเข็มนาฬิกา
- กระดกข้อเท้าขึ้นและลง - เหยียดนิ้วเท้าและงอนิ้วเท้า
- กางนิ้วเท้าแยกออกจากกันและหุบนิ้วเท้าเข้าหากัน ผู้ป่วยควรทำ 5-10 ครั้งในแต่ละท่าและแต่ละข้างทุก 2 ชม. ในขณะที่ผู้ป่วยกำลังตื่นนอน



# การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด

## : การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัด

### การลุกเดินโดยเร็ว (Early ambulation)

**วัตถุประสงค์:** ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจและระบบการไหลเวียนของเลือด ส่งเสริมให้แผลผ่าตัดหายเร็วขึ้น ส่งเสริมให้ระบบย่อยอาหารฟื้นตัวและสามารถทำงานได้เร็วขึ้น

**ภาวะแทรกซ้อนกรณีไม่ปฏิบัติ:** ปอดบวม แผลกดทับ DVT ท้องผูก ท้องอืด การปวดท้องจากแก๊ส และภาวะที่มีพังผืดรัดลำไส้

### วิธีปฏิบัติ

- ภายใน 24 ชั่วโมงแรก กระตุ้นพลิกตะแคงตัวเปลี่ยนท่านอนอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
- ระยะหลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง : พยายามให้ผู้ป่วยลุกนั่งบนเตียง ห้อยขาข้างเตียง
- วันต่อมา ลุกเดินรอบเตียง และเดินออกจากเตียงไปเข้าห้องน้ำ หรือรอบหอผู้ป่วย



# การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด

## : การเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร/หลักฐานทางกฎหมาย ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

### การเซ็นใบยินยอมผ่าตัด

**วัตถุประสงค์:** เพื่อให้ผู้ป่วยรับทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการผ่าตัด ผลประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึง  
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการผ่าตัด \*จะต้องเขียนให้ชัดเจนทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ผู้ป่วยที่ต้องทำการตัดอวัยวะในร่างกายออก

### วิธีปฏิบัติ

- กรณีที่ผู้ป่วยยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ผู้ปกครอง บิดา หรือมารดาเป็นผู้เซ็นใบอนุญาตผ่าตัด
- กรณีจำเป็นต้องทำการผ่าตัดฉุกเฉินและกรณีจำเป็น (ผู้ป่วยตกอยู่ในภาวะที่เป็นอันตรายต่อชีวิต (Life-threatening situation) เช่น อุบัติเหตุรถชน ศีรษะกระแทกพื้นมีเลือดคั่งในสมอง และไม่สามารถติดต่อญาติได้): แพทย์สามารถตัดสินใจผ่าตัด เนื่องจากเป็นกรณีที่จะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ

# การพยาบาลตามปัญหาของผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด

## : การส่งผู้ป่วยไปเข้าห้องผ่าตัด

### ตรวจสอบ

ผ่าตัดถูกคน\*\*

- ถอดฟันปลอม แว่นตา เครื่องช่วยฟัง ของมีค่า
- เล็บที่ทาไว้ควรลบออกให้สะอาด
- การทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำสระผมควรทำให้เรียบร้อยก่อนไปผ่าตัด

ขอบคุณจ้า

